

La enfermedad de Peyronie causa una cicatriz (placa) dentro del pene que puede curvarlo durante la erección, a veces dificultando las relaciones. La plicatura del pene endereza la curva colocando puntos en el lado más largo del pene para “recogerlo” suavemente e igualarlo al lado más corto. Esta hoja explica cómo funciona, cómo prepararse y qué esperar.

Acerca de este procedimiento

En la enfermedad de Peyronie, la cicatriz tensa más un lado del pene, por lo que se curva con la erección. La plicatura lo endereza cosiendo y acortando el **lado más largo (externo)** de la curva hasta igualar ambos lados. No se corta la cicatriz ni se usa injerto — es la más sencilla y corta de las cirugías para enderezar, con el **menor riesgo de nuevos problemas de erección**.

Es una buena opción cuando:

- Su curva es moderada y no muy compleja
- Sus **erecciones son buenas** (con o sin ayuda de pastillas)
- Su pene es bastante largo y acepta un pequeño acortamiento

Qué saber

La principal desventaja es cierto **acortamiento** del pene — suele ser de 1–2 cm. Muchos hombres lo sobreestiman; como se corrige la curva, la longitud recta útil suele ser igual que antes. Cerca de **9 de cada 10** hombres logran una erección bastante recta para tener relaciones. Puede que **sienta los puntos** bajo la piel (es común y casi nunca molesta). La meta es un pene bastante recto para relaciones cómodas, no siempre perfectamente recto.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Enfermedad de Peyronie

Una cicatriz en el pene que lo hace curvar durante la erección.

Placa

El parche de cicatriz que causa la curva.

Plicatura

Enderezar el pene cosiendo y acortando el lado más largo.

Erección artificial

Una erección creada en el quirófano (con una inyección) para que el cirujano mida y revise la curva.

Circuncisión

Extirpación del prepucio — a veces se hace en el mismo acto si usted no está circuncidado.

Dispositivo de vacío

Una bomba que a veces se usa durante la recuperación para conservar longitud y erecciones.

Anestesia general

Medicina que lo mantiene dormido y sin dolor durante la cirugía.

¿LE DOLERÁ? La cirugía se hace con anestesia general, espinal o local, así que no siente nada durante ella. Después, espere hinchazón, moretones y dolor del pene por 1–2 semanas — el hielo, el soporte y los analgésicos ayudan. Es una cirugía corta (a menudo cerca de una hora) y suele ser el mismo día. Puede haber una sonda por poco tiempo.

Cómo prepararse (antes de la cirugía)

- Se hace con **anestesia general, espinal o local** — siga todas las instrucciones (ayuno y qué medicinas suspender, incluidos anticoagulantes).
- Su Peyronie debe estar **estable** (la curva y el dolor sin cambios por varios meses) — su cirujano confirma que es el momento adecuado.
- No fume**; toda infección se trata primero y recibirá antibióticos. Si no está circuncidado, puede hacerse una circuncisión a la vez — pregunte a su cirujano.

Avise a su equipo con anticipación si:

- Tiene **erecciones débiles** o toma medicina para las erecciones
- Toma un anticoagulante o tuvo cirugía previa del pene

Qué sucede durante la cirugía

- Está dormido o adormecido con anestesia y se le dan antibióticos.
- Se **crea una erección con una inyección** para que el cirujano vea la curva, luego se colocan puntos en el lado más largo para recoger y enderezar el pene.
- El resultado se revisa con otra erección y se cierra la piel (puede hacerse una circuncisión a la vez si hace falta).

Después de la cirugía

- Espere **hinchazón, moretones y dolor** por 1–2 semanas. Use hielo, ropa interior de soporte y analgésicos; mantenga el área limpia.
- Si se colocó una sonda, suele retirarse la mañana siguiente.
- Evite las relaciones unas 4–6 semanas** para que sane la reparación.
- Su equipo puede indicarle una **pastilla de erección en dosis baja** y/o un **dispositivo de vacío** a diario durante la recuperación para conservar longitud y erecciones.

Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre o escalofríos, o más enrojecimiento, dolor, hinchazón o secreción en la herida
- No puede orinar
- Hinchazón o dolor intenso o que empeora, o sangrado abundante

TRES COSAS PARA RECORDAR

- La plicatura endereza la curva cosiendo el lado más largo del pene — no se corta la cicatriz ni se usa injerto. Es la cirugía más sencilla, con el menor riesgo de nuevos problemas de erección.
- La desventaja es cierto **acortamiento** (suele ser 1–2 cm), aunque corregir la curva a menudo recupera longitud útil; ~9 de cada 10 hombres logran una erección bastante recta. Puede sentir los puntos bajo la piel.
- Su Peyronie debe estar estable primero; no fume. Después, evite las relaciones ~4–6 semanas y siga el plan de recuperación (pastilla / dispositivo de vacío). Llame si tiene fiebre, hinchazón intensa o no puede orinar.